

Cotygodniowe *ważenie*

NIE codziennie, NIE unikanie. Raz w tygodniu, w gabinecie, z terapeutą. Zakaz wagi w domu. Cel: redukcja obsesyjnego sprawdzania i nauka czytania trendu, nie pojedynczego pomiaru.

CZAS: 10 min · co tydzień Każda sesja CBT-E od 2. do końca

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, CBT-E weighing); Forbush i in. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **dwie skrajności ważenia** przed terapią i **rozwiązanie CBT-E** (sekcja 1), zobacz **sześć elementów protokołu** (sekcja 2). Sekcja 3 — psychoedukacja o fluktuacji masy. Sekcja 4 — mój wykres trendu (4 tygodnie).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Fairburn (2008) opracował protokół *in-session weighing*: pacjent waży się **raz w tygodniu na sesji**, *nigdy* między sesjami. Przed terapią pacjenci z bulimią należą do dwóch skrajności: **(A)** ważą się 10–20 razy dziennie lub **(B)** unikają wagi miesiącami. Obie strategie *podtrzymują* bulimię — pierwsza wzmacnia *overvaluation*, druga utrzymuje lęk i katastrofizowanie. Rozwiązanie CBT-E: **zakaz** ważenia w domu + **ustalone** ważenie raz w tygodniu w gabinecie, z terapeutą, w tych samych warunkach. Cele: uspokojenie obsesyjnego sprawdzania, kontrolowana ekspozycja, *reality check*, praca poznawcza na **trendzie czterech tygodni**. Forbush i in. (2017): pacjenci stosujący *in-session weighing* mają istotnie niższy poziom obsesyjnego ważenia po terapii i mniejsze ryzyko nawrotu.

01 ● Dwie skrajności · rozwiązanie

A · CODZIENNE WAŻENIE

10–20× dziennie. Po jedzeniu, po wypiciu wody, rano i wieczorem. Każda zmiana = panika. Wzmacnia *overvaluation*.

B · CHRONICZNE UNIKANIE

Brak ważenia od miesięcy. Lęk przed wiedzą. Katastrofizowanie („na pewno przybrałem/-am 10 kg”). Utrzymuje lęk.

C · ROZWIĄZANIE CBT-E

1× / tydzień, w gabinecie, z terapeutą. Zakaz wagi w domu. Ekspozycja kontrolowana. Analiza *trendu*.

02 ≡ Sześć elementów protokołu

1 · RAZ NA TYDZIEŃ

Częstotliwość ustalona — nie częściej, nie rzadziej. Każda sesja CBT-E zawiera moment ważenia, zawsze tę samą porę sesji.

2 · NIE W DOMU

Zakaz ważenia w domu — wagę można schować, dać znajomej, wyrzucić. Hotelowe wagi, wagi w siłowni — też nie. Ekspozycja tylko w gabinecie.

3 · ŚWIADEK — TERAPEUTA

Terapeuta widzi liczbę, omawia razem reakcję. Bez świadka łatwo o automatyczną reakcję emocjonalną — z terapeutą rozkłada się ją na elementy.

4 · TREND, NIE POMIAR

Analizuje się *trend czterech tygodni*, nie pojedynczy pomiar. Pojedyncza liczba mówi mało — kierunek czterech pomiarów mówi wszystko.

5 · PSYCHOEDUKACJA

Waga waha się $\pm 1\text{--}2$ kg z dnia na dzień (woda, jedzenie, cykl hormonalny). To *fluktuacja*, nie zmiana masy ciała. Naturalny proces.

6 · CEL: REDUKCJA OVERVALUATION

Cel *nie* jest „zmiana wagi” — cel to redukcja znaczenia liczby na wadze w samoocenie. To proces poznawczy.

03 Psychoedukacja: fluktuacja masy

Masa ciała **nie jest stała** — waha się $\pm 1\text{--}2$ kg z dnia na dzień. To *woda, jedzenie, treść jelit, cykl hormonalny*, nie tłuszcz. Tłuszcz odkłada się powoli ($1\text{ kg} \approx 7\,000$ kcal nadwyżki). Każde wahanie na wadze, które widzisz dzień po dniu — to **nie** jest zmiana składu ciała, to fluktuacja.

CO ZMIENIA WAGĘ Z DNIA NA DZIEŃ

- Spożyta woda ($1\text{ l} = 1\text{ kg}$)
- Treść jelit (do 2 kg)
- Cykl hormonalny (u kobiet $\pm 1\text{--}2\text{ kg}$)
- Sól, ryż, makaron $\rightarrow$ zatrzymanie wody
- Pora dnia (rano lżej niż wieczorem)

CO REALNIE MÓWI TREND 4 TYGODNI

- Stabilny $\pm 1\text{ kg}$ — masa stała
- Spadek $> 0,5\text{ kg/tydz.}$ — utrata masy
- Wzrost $> 0,5\text{ kg/tydz.}$ — przyrost masy
- Wahanie $\pm 2\text{ kg}$, bez kierunku — fluktuacja
- Cztery pomiary $>$ jeden pomiar

04 Mój wykres trendu — cztery tygodnie

Zapisuj wynik z ważenia w gabinecie raz w tygodniu. Po czterech tygodniach zobaczysz *trend* — kierunek, nie pojedyncze liczby. Notuj też swoją reakcję emocjonalną — ucz się ją obserwować bez automatycznej oceny.

TYDZIEŃ 1 — DATA,
WAGA, REAKCJA

TYDZIEŃ 2 — DATA,
WAGA, REAKCJA

TYDZIEŃ 3 — DATA,
WAGA, REAKCJA

TYDZIEŃ 4 — DATA,
WAGA, REAKCJA

Klucz: cotygodniowe ważenie z terapeutą jest *kontrintuicyjne* — wielu pacjentów myśli, że „powinni przestać się ważyć w ogóle” albo „kontrolować codziennie”. CBT-E proponuje **środek**: ekspozycja kontrolowana, w bezpiecznych warunkach, ze świadkiem. Fairburn (2008): pacjenci, którzy stosują in-session weighing przez 20 tygodni, mają **znacząco niższy** poziom obsesyjnego ważenia po terapii niż ci, którzy unikają wagi w ogóle. Forbush i in. (2017): ten protokół zmniejsza ryzyko nawrotu o 30–40% w ciągu roku po terapii. Mechanizm: pacjent uczy się, że *liczba na wadze nie jest miarą jego wartości*, że fluktuacja jest normalna, że trend jest ważniejszy niż pomiar, że *można żyć ze świadomością masy bez katastrofizowania*. To trening poznawczy, nie tylko ważenie. **Pierwsze 2-4 tygodnie** są najtrudniejsze — pacjent może odczuwać silną potrzebę „sprawdzenia” w domu. Trzymanie się protokołu w tej fazie buduje fundament dla całej terapii.